

Problem Podwójnej Empatii

Double Empathy Problem, rewizja założeń, nowe dowody, implikacje kliniczne

dr inż. Mateusz Pomianek

Damian Milton (2012) · Crompton et al. (2020) · Cameron & Slessor (2021)





Paradygmat Deficytu

Dominujące ujęcie
autyzmu
przed 2012 rokiem

KONTEKST HISTORYCZNY

Tradycyjne modele teorii umysłu w ASD

Baron-Cohen (1985)

Test fałszywych przekonań, dzieci z ASD „nie przechodzą” zadania Sally-Anne. Wniosek: deficyt ToM.

"Ślepotą na umysł" (mindblindness)

Autyzm jako wrodzona niezdolność do modelowania stanów mentalnych innych.

Konsekwencja kliniczna

Trudności społeczne osób autystycznych = deficyt patologii jednostki, nie różnica między osobami.

Podejście to ignoruje perspektywę neurotypowych jako równie ograniczoną w rozumieniu osób autystycznych, co stało się punktem wyjścia dla Milтона (2012).

Problem Podwójnej Empatii

*"Trudności w interakcjach społecznych między osobami autystycznymi, a neurotypowymi wynikają ze **wzajemnych** problemów ze zrozumieniem oraz różnic w habituacji i socjalizacji, a nie z patologii charakterystycznej wyłącznie dla jednej strony."*

— Damian Milton, *Disability & Society*, 2012



Wzajemność

Problem dotyczy OBU stron, zarówno autystycznej, jak i neurotypowej.



Habituacja

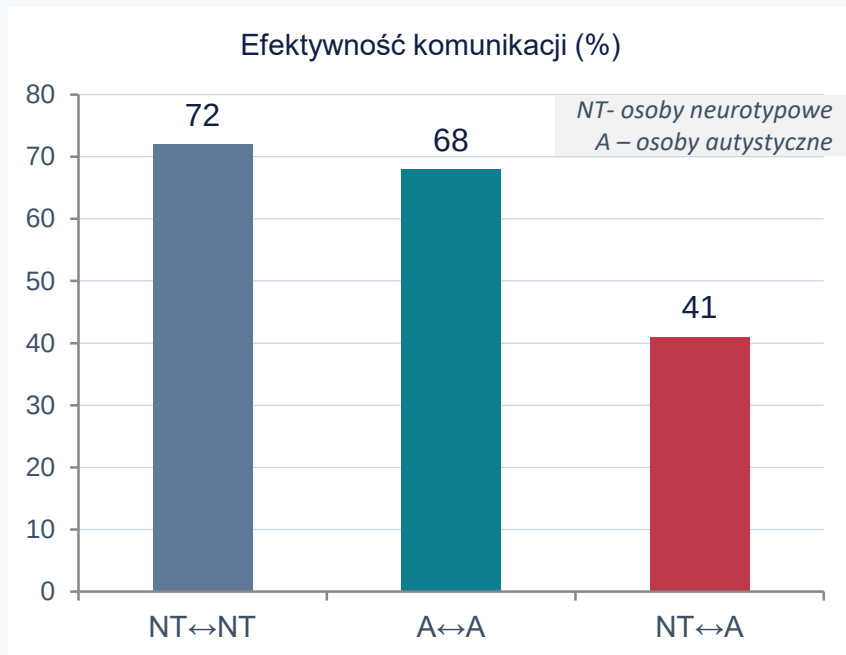
Trudności są efektem odmiennych doświadczeń socjalizacyjnych, nie wrodzonego deficytu.



Reframing

Różnica ≠ niedobór.
Inny styl komunikacji to nie patologia.

Badania potwierdzające hipotezę DEP



Źródło: Crompton, Sharp, Axbey, Fletcher-Watson et al. (2020). Autism.

Crompton et al. (2020)

Trójstronne badanie łańcucha telefonicznego: pary NT-NT, A-A, NT-A. Pary A↔A dorównywały efektywności NT-NT. Mieszane pary wykazywały istotne obniżenie transferu informacji.

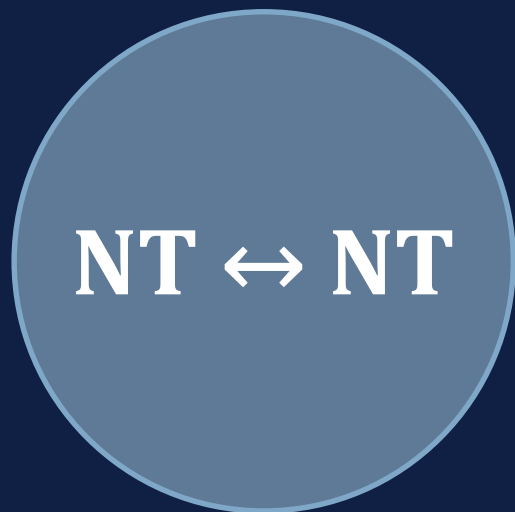
Mitchell, Sheppard & Cassidy (2021)

Meta-analiza 87 badań: brak potwierdzenia globalnego deficytu ToM u osób autystycznych. Wyniki zależne od kontekstu społecznego i znajomości rozmówcy.

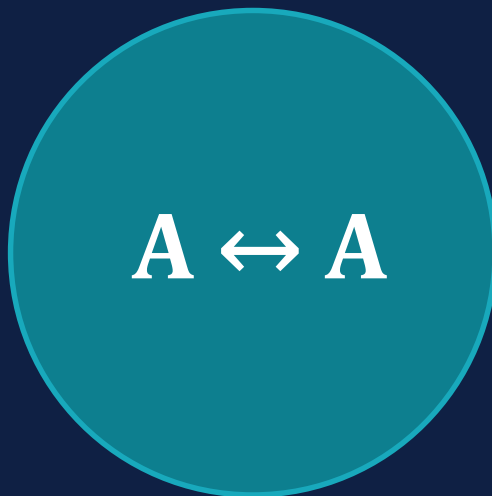
Murray, Milton & Spoor (2021)

Badania nagrań interakcji: sędziowie neurotypowi oceniali pary NT-NT i A-A jako równie kompetentne społecznie, różnica pojawiała się tylko w parach mieszanych.

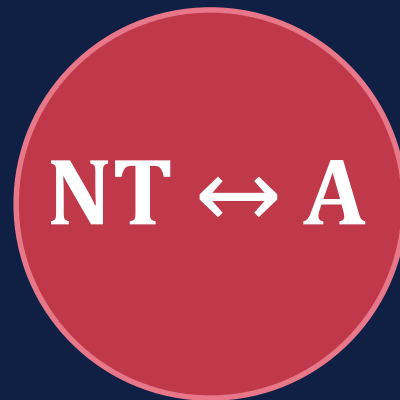
Efektywność komunikacji, a podobieństwo neurotypu



72%
efektywności



68%
efektywności



41%
efektywności

Osoby autystyczne wykazują pełną efektywność komunikacyjną, lecz wyłącznie w interakcjach z osobami o podobnym neurotypie

Maskowanie i kamuflaż, czyli jaka jest cena adaptacji

Czym jest maskowanie?

Maskowanie (ang. masking/camouflaging) to świadome lub nieświadome tłumienie autystycznych cech i naśladowanie neurotypowych wzorców zachowania w celu uniknięcia stygmatyzacji lub odrzucenia społecznego.

Wyczerpanie poznawcze

Stałe monitorowanie i korygowanie własnych reakcji pochłania zasoby wykonawcze.

Opóźniona diagnoza

Zwłaszcza u kobiet i dziewcząt. Skuteczne maskowanie ukrywa symptomy przed klinicystami.

Zdrowie psychiczne

Przewlekły stres maskowania → depresja, lęk, wypalenie autystyczne (autistic burnout).

Dane epidemiologiczne

78%

osób autystycznych stosuje maskowanie (Hull et al. 2020)

4–6×

wyższe ryzyko depresji u osób autystycznych z maskowaniem

~3 lata

średnie opóźnienie diagnozy u kobiet ze względu na maskowanie

Kwestionowanie kanonicznego modelu deficytu społecznego

✗ Stary paradygmat

- **Deficyt ToM** jako cecha patologiczna osoby autystycznej
- **Cel terapii:** upodobnienie się do norm neurotypowych
- **Trudności** są wynikiem „braków” autystycznych
- **Brak uwzględnienia** asymetrii rozumienia
- **Terapia ABA:** tłumienie autystycznych zachowań (tragiczne w skutkach!)



✓ Paradygmat DEP

- Trudności są wzajemne, kontekstualne, relacyjne
- Spektrum autyzmu jest różnicą neurobiologiczną, a nie deficytem
- Cel terapii: adaptacja obu środowisk
- **Uznanie asymetrii** wymagań adaptacyjnych
- Interwencje wspierające tożsamość autystyczną

Jak DEP zmienia proces diagnozy neuropsychologicznej?



Obserwacja narzędzi

ADOS-2 i ADI-R zostały znormalizowane na populacjach neurotypowych. DEP sugeruje konieczność rewizji progów klinicznych i uwzględnienia kontekstu mieszanej interakcji.



Rola płci i maskowania

Kobiety i dziewczęta z ASD są częściej pomijane w diagnozie właśnie wskutek skutecznego maskowania. Klinicyści powinni wdrażać protokoły wrażliwe na płeć.



Środowisko badania

Ocena powinna uwzględniać interakcje z rówieśnikami o podobnym neurotypie. Deficyty widoczne tylko w parach mieszanych, nie powinny być automatycznie klasyfikowane jako patologia.



Historia adaptacji

Wywiad diagnostyczny powinien eksplorować historię maskowania, wypalenia autystycznego i kosztów adaptacji, a nie tylko obecną symptomatologię.

Modyfikacje podejścia terapeutycznego dla osób neuroróżnorodnych



Odrzucenie celu neurotypizacji

Terapia nie powinna dążyć do upodobnienia zachowań autystycznych do neurotypowych norm. Celem jest dobrostan i autentyczność, a nie konformizm.



Sojusz terapeutyczny

Budowanie sojuszu wymaga aktywnego dostosowania języka, tempa i modalności. Unikanie małomówności jako wskaźnika oporu, może on być stylem komunikacji.



Praca z maskowaniem

Bezpieczna przestrzeń do rezygnacji z maskowania. Edukacja klienta/pacjenta o realnych kosztach adaptacji i prawie do swojej autentyczności autystycznej.



Dostosowanie modalności

Alternatywne formy komunikacji (pisemna, symboliczna), skrócone sesje, jasna struktura, unikanie idiomów i metafor wieloznacznych.



Walidacja doświadczeń

Uznanie autystycznych doświadczeń jako ważnych i autentycznych, a nie jako symptomów wymagających korekty. Praca z tożsamością autystyczną jako zasobem.



Perspektywa neuroróżnorodności

Włączenie modelu neuroróżnorodności zamiast modelu medycznego. Terapeuta jako sojusznik, a nie ekspert normalizujący.

Konkretne wytyczne dla psychologów i neuropsychologów

01

Dokumentuj zasoby, a nie tylko deficyty

Profil neuropsychologiczny powinien uwzględniać silne strony komunikacji autystycznej, nie tylko odchylenia od norm.

02

Pytaj wprost o maskowanie

Włącz do wywiadu pytania o stosowane strategie maskowania, ich koszt emocjonalny i historię wypalenia autystycznego.

03

Dostosuj środowisko badania

Ogranicz bodźce sensoryczne, zapewnij przewidywalną strukturę sesji, oferuj przerwy bez konieczności wyjaśnień.

04

Aktualizuj wiedzę

Uwzględniaj literaturę participatory research, badania współprowadzone z osobami autystycznymi jako ekspertami.

05

Unikaj neurotypowych miar empatii

Standardowe skale empatii (np. IRI, EQ) zostały skalibrowane na neurotypowych populacjach i mogą być niewymierne dla osób autystycznych.

06

Wspieraj tożsamość autystyczną

Badania wykazują, że silna tożsamość autystyczna koreluje z wyższym dobrostanem i niższym poziomem lęku (Cage et al., 2018).

Pytania otwarte i perspektywy badawcze

Participatory research

Współprojektowanie badań z samorzecznikami i autystycznymi naukowcami, przełamanie asymetrii władzy epistemologicznej.

Rewizja narzędzi ADOS/ADI

Tworzenie protokołów diagnostycznych uwzględniających DEP i różnicowanie kontekstualne komunikacji.

Neurobiologia wypalenia

Autistic burnout jako odrębna jednostka kliniczna: mechanizmy neurobiologiczne, biomarkery, interwencje.

Interwencje środowiskowe

Programy edukacyjne dla neurotypowych partnerów interakcji, zmniejszenie obciążenia adaptacyjnego po stronie osób autystycznych.

Tożsamość i dobrostan

Longitudinalne badania związku między identyfikacją autystyczną, maskowaniem i wskaźnikami zdrowia psychicznego.

Kluczowe publikacje

- ▶ Milton, D. (2012). On the ontological status of autism. *Disability & Society*.
- ▶ Crompton, C., et al. (2020). Autistic peer-to-peer information transfer. *Autism*.
- ▶ Hull, L., et al. (2020). Towards operationalising camouflaging. *J. Autism Dev. Disord.*
- ▶ Cage, E. & Troxell-Whitman, Z. (2019). Understanding reasons for masking. *J. Autism Dev. Disord.*
- ▶ Pearson, A. & Rose, K. (2021). A conceptual analysis of autistic masking. *Autism Adulthood*.
- ▶ Murray, F., et al. (2022). Double empathy in everyday contexts. *Front. Psychol.*

Problem **Podwójnej Empatii**: co to zmienia dla klinicysty?

- 1 Trudności w interakcji NT $\leftrightarrow$ A są wzajemne i kontekstualne, nie jednostronne.
- 2 Osoby autystyczne komunikują się efektywnie z innymi autystykami, a to falsyfikuje hipotezę globalnego deficytu społecznego.
- 3 Maskowanie ma realne koszty kliniczne: wyczerpanie, depresja, opóźnienie diagnozy.
- 4 Psychoterapia powinna celować w dobrostan i autentyczność, nie w neurotypizację.
- 5 Klienci muszą dostosować narzędzia, środowisko i cele interwencji do DEP.



B

Różnorodność neurologiczna jest cechą ludzkiej populacji, a nie zbiorem deficytów wymagających korekcji.